

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE INTEGRATO

ISO 9001 · ISO 7101 · ISO 45001 · ISO 14001 · PAS 24000
ISO 30415 · UNI PdR 125 · ISO 37001 · ISO 27001 · ISO 15189 · Mod. 231

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-MAN001_00	00	12/04/2026	11
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSGI	AD – Francesco Epifani	Riservato	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Iacopo Cupelli	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
12/04/2026	12/04/2026	12/04/2026

Sommario

1. Scopo e campo di applicazione.....	3
2. Riferimenti normativi.....	3
3. Termini, definizioni e abbreviazioni.....	3
4. Contesto dell'organizzazione (cl. 4 HLS).....	4
4.1 Comprensione dell'organizzazione e del suo contesto.....	4
4.2 Parti interessate.....	4
4.3 Campo di applicazione del SGI.....	4
4.4 Il Sistema di Gestione Integrato e i suoi processi.....	4
5. Leadership (cl. 5 HLS).....	5
5.1 Leadership e impegno.....	5
5.2 Politica Integrata.....	5
5.3 Ruoli, responsabilità e autorità.....	5
6. Pianificazione (cl. 6 HLS).....	5
6.1 Rischi e opportunità.....	5
6.2 Obiettivi e pianificazione.....	5
7. Supporto (cl. 7 HLS).....	6
7.1 Risorse.....	6
7.2 Competenze e consapevolezza.....	6
7.3 Comunicazione.....	6
7.4 Informazioni documentate.....	6
8. Attività operative (cl. 8 HLS).....	6
8.1 Pianificazione e controllo operativo.....	6
8.2 Erogazione delle prestazioni diagnostiche.....	6
8.3 Fornitori e approvvigionamento.....	7
9. Valutazione delle prestazioni (cl. 9 HLS).....	7
9.1 Monitoraggio e misurazione.....	7
9.2 Audit interni.....	7
9.3 Riesame della Direzione.....	7
10. Miglioramento (cl. 10 HLS).....	7
11. Architettura documentale del SGI: le 18 aree.....	8
12. Matrice di correlazione norme e processi.....	9
12. Storico delle revisioni.....	9

1. Scopo e campo di applicazione

Il presente Manuale descrive il Sistema di Gestione Integrato (SGI) di Toscana Diagnostica S.r.l., struttura sanitaria privata accreditata con sede in Firenze, Viale Belfiore 55, operante nei settori della diagnostica di laboratorio, diagnostica per immagini, medicina specialistica, medicina del lavoro e riabilitazione, attraverso una rete integrata di laboratori di analisi, centri diagnostici e punti prelievo sul territorio toscano.

Il Manuale è il documento apicale del SGI e ha lo scopo di: descrivere l'architettura del sistema di gestione, le sue interazioni e i riferimenti normativi; definire il campo di applicazione e il perimetro organizzativo; illustrare i processi, le responsabilità e le risorse; fornire il quadro di riferimento per tutti i documenti di livello inferiore (politiche, procedure, istruzioni, protocolli, regolamenti, piani, moduli); garantire conformità simultanea a tutti gli standard adottati.

Il Campo di Applicazione del SGI è: erogazione di prestazioni sanitarie in regime ambulatoriale nell'ambito della Diagnostica di Laboratorio (Patologia Clinica, Biochimica Clinica, Microbiologia e Virologia, Genetica Medica), Diagnostica per Immagini (radiologia digitale, mammografia, ortopantomografia, MOC, TAC, Risonanza Magnetica, ecografia, elettromiografia), Endoscopia, Medicina Fisica e Riabilitazione, Medicina Specialistica e Medicina del Lavoro.

2. Riferimenti normativi

Il SGI di Toscana Diagnostica è conforme simultaneamente ai seguenti standard internazionali, nazionali e legislativi:

Norma / Riferimento	Ambito	Titolo
ISO 9001:2015	Qualità	Sistema di gestione per la qualità: requisiti
ISO 7101:2023	Qualità sanitaria	Gestione della qualità nelle organizzazioni sanitarie
ISO 45001:2018	SSL	Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro
ISO 14001:2015	Ambiente	Sistemi di gestione ambientale
PAS 24000:2022	Gestione sociale	Sistema di gestione sociale: requisiti
ISO 30415:2021	D&I	Gestione della diversità e inclusione nelle risorse umane
UNI PdR 125:2022	Parità di genere	Sistema di gestione per la parità di genere
ISO 37001:2016	Anticorruzione	Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione
ISO 27001:2022	Sicurezza info	Sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni
D.Lgs. 231/2001	Mod. 231	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
ISO 15189:2022	Laboratorio	Requisiti particolari per la qualità e la competenza dei laboratori medici – obiettivo di accreditamento dal 2027
Reg. UE 2016/679	GDPR	Protezione dei dati personali
D.Lgs. 81/2008	T.U. Sicurezza	Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro
LR Toscana 51/2009	Accreditamento	Autorizzazione e accreditamento strutture sanitarie

3. Termini, definizioni e abbreviazioni

SGI: Sistema di Gestione Integrato. **RSGI:** Responsabile del Sistema di Gestione Integrato. **HLS:** High Level Structure (Annex SL), struttura ad alto livello comune alle norme ISO. **PDCA:** Plan-Do-Check-Act, ciclo di miglioramento continuo. **DG:** Direzione Generale. **AD:** Amministratore Delegato. **DS:** Direttore Sanitario. **DQ:** Direzione Qualità.

OdV: Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001. **CO:** Compliance Officer. **DPO:** Data Protection Officer. **RSPP:** Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione. **LIS:** Laboratory Information System. **RIS:** Radiology Information System. **PACS:** Picture Archiving and Communication System. **ISMS:** Information Security Management System.

4. Contesto dell'organizzazione (cl. 4 HLS)

4.1 Comprensione dell'organizzazione e del suo contesto

Toscana Diagnostica è una rete sanitaria integrata dedicata alla diagnostica di laboratorio e alla diagnostica per immagini, con un sistema di oltre 20 strutture operative distribuite su 4 province toscane. Il modello industriale è fondato sull'architettura hub & spoke, con il Laboratorio di Analisi centralizzato a Sesto Fiorentino come centro produttivo baricentrico, e una rete diffusa di centri diagnostici e punti prelievo di prossimità.

Il contesto esterno è caratterizzato da un sistema sanitario regionale avanzato ma sottoposto a crescenti pressioni, da un mercato privato della diagnostica in espansione (spesa out of pocket al 23% del totale nel 2023), da un quadro regolatorio strutturato (LR 51/2009) e da un mercato frammentato privo di un operatore dominante a scala regionale. Il contesto interno è definito dalla fase di avvio operativo, dal Progetto Industriale approvato e dal modello organizzativo snello con governance centrale e outsourcing qualificato.

L'analisi del contesto è condotta con cadenza almeno annuale in sede di Riesame della Direzione (TD-SGI-PRO002) e aggiornata in funzione di modifiche normative, organizzative o di mercato significative.

4.2 Parti interessate

Le parti interessate rilevanti e le loro esigenze e aspettative sono identificate e monitorate in conformità alla clausola 4.2 HLS. Comprendono: pazienti e cittadini, professionisti sanitari, dipendenti e collaboratori, medici di medicina generale, Regione Toscana e ASL, istituti di credito e investitori, fornitori tecnologici, imprese (B2B), comunità locale, autorità di controllo. Le esigenze e aspettative sono dettagliate nel Rapporto di Riesame Iniziale (TD-SGI-PRO002).

4.3 Campo di applicazione del SGI

Il campo di applicazione è definito nella Sezione 1 del presente Manuale. Non sono previste esclusioni di requisiti delle norme applicabili, fatte salve le clausole non pertinenti alla natura delle attività (ad esempio, la clausola 8.3 della ISO 9001 sulla progettazione e sviluppo non si applica in quanto le prestazioni diagnostiche seguono protocolli standardizzati e normativa sanitaria vigente). Il perimetro è dinamico e viene esteso progressivamente in coerenza con il Piano di Crescita.

4.4 Il Sistema di Gestione Integrato e i suoi processi

Il SGI è strutturato secondo l'approccio per processi previsto dalla clausola 4.4 HLS. I processi sono classificati in tre macrocategorie: processi di governo (pianificazione strategica, riesame della direzione, governance clinica, compliance, gestione finanziaria), processi operativi (diagnostica di laboratorio, diagnostica per immagini, gestione del paziente, logistica campioni, servizi B2B, M&A, apertura nuovi centri), processi di supporto (risorse umane, infrastruttura, sistemi informativi, approvvigionamenti, gestione ambientale, SSL, audit, comunicazione).

Per ciascun processo sono definiti: input e output attesi, sequenza e interazioni, criteri e metodi di controllo, risorse necessarie, responsabilità e autorità, rischi e opportunità, indicatori di monitoraggio. La mappa dei processi è riesaminata annualmente in sede di Riesame della Direzione.

5. Leadership (cl. 5 HLS)

5.1 Leadership e impegno

L'Alta Direzione dimostra leadership e impegno nei confronti del SGI assumendo la responsabilità dell'efficacia del sistema, assicurando la compatibilità tra politica, obiettivi e indirizzo strategico, promuovendo l'approccio per processi e il risk-based thinking, garantendo le risorse necessarie, comunicando l'importanza del SGI e sostenendo il miglioramento continuo. L'impegno si estende a ciascun ambito specifico: sicurezza del paziente (ISO 7101), consultazione e partecipazione dei lavoratori (ISO 45001), protezione dell'ambiente (ISO 14001), prevenzione della corruzione (ISO 37001), sicurezza delle informazioni (ISO 27001), responsabilità sociale (PAS 24000), parità di genere (UNI PdR 125), diversità e inclusione (ISO 30415).

5.2 Politica Integrata

La Politica Integrata del SGI (TD-SGI-POL001) è il documento che formalizza gli impegni dell'Alta Direzione. Si articola in nove principi fondamentali: eccellenza diagnostica senza compromessi (ISO 9001, ISO 7101); protezione della salute e della sicurezza (ISO 45001); responsabilità ambientale (ISO 14001); dignità del lavoro e responsabilità sociale (PAS 24000); diversità, equità e inclusione (ISO 30415); parità di genere (UNI PdR 125); tolleranza zero verso la corruzione (ISO 37001, D.Lgs. 231/2001); protezione dei dati e sicurezza delle informazioni (ISO 27001); miglioramento continuo (clausola 10 HLS). La Politica è comunicata a tutti i livelli e resa disponibile alle parti interessate.

5.3 Ruoli, responsabilità e autorità

L'organizzazione adotta un modello snello con le seguenti figure chiave: Amministratore Delegato (responsabilità complessiva del SGI), Direttore Sanitario (governo clinico, accreditamento, qualità sanitaria), RSGI / Direzione Qualità (coordinamento SGI, audit, NC, documentazione), Compliance Officer (anticorruzione, Mod. 231, whistleblowing), DPO / IT Security (protezione dati, ISMS), RSPP (salute e sicurezza), Direttore Tecnico di Laboratorio (qualità analitica), Risorse Umane (D&I, parità di genere, gestione sociale). L'organigramma e le deleghe sono formalizzati e aggiornati con cadenza annuale.

6. Pianificazione (cl. 6 HLS)

6.1 Rischi e opportunità

In conformità alla clausola 6.1 HLS, l'organizzazione identifica, valuta e gestisce i rischi e le opportunità derivanti dal contesto, dalle parti interessate e dai requisiti del SGI. La valutazione dei rischi è condotta con approccio integrato per tutti gli ambiti normativi e include: rischi strategici e operativi (integrazione post-acquisizione, regolatorio, tecnologico), rischi per la sicurezza delle informazioni (ISO 27001), rischi di corruzione (ISO 37001), rischi per la salute e sicurezza (ISO 45001), aspetti ambientali significativi (ISO 14001), rischi sociali e di governance (PAS 24000). L'analisi dei rischi è documentata nel Rapporto di Riesame (TD-SGI-PRO002) e riesaminata almeno annualmente.

6.2 Obiettivi e pianificazione

Gli obiettivi del SGI sono definiti nel Piano degli Obiettivi (TD-SGI-PLN001), in coerenza con la Politica Integrata, e sono stabiliti per ciascun ambito normativo con indicatori di prestazione, tempistiche e responsabilità assegnate. La pianificazione segue i criteri di coerenza, misurabilità, monitoraggio, comunicazione e aggiornamento periodico previsti dalla clausola 6.2 HLS.

7. Supporto (cl. 7 HLS)

7.1 Risorse

L'organizzazione determina e fornisce le risorse necessarie per l'istituzione, l'implementazione, il mantenimento e il miglioramento continuo del SGI. Le risorse comprendono: persone (personale qualificato per ogni funzione), infrastruttura (apparecchiature diagnostiche, sistemi informativi, strutture fisiche), ambiente per il funzionamento dei processi (condizioni ambientali, sicurezza, ergonomia), risorse per il monitoraggio e la misurazione (strumenti tarati, software, indicatori), conoscenza organizzativa (know-how clinico, competenze gestionali, best practice di settore).

7.2 Competenze e consapevolezza

L'organizzazione determina le competenze necessarie per ogni ruolo, assicura formazione adeguata, valuta l'efficacia delle azioni intraprese e conserva le evidenze documentali. La formazione è pianificata annualmente e copre gli ambiti specifici del SGI: qualità e sicurezza del paziente, salute e sicurezza sul lavoro, gestione ambientale, anticorruzione, sicurezza delle informazioni, diversità e inclusione, parità di genere, responsabilità sociale. La consapevolezza è promossa attraverso comunicazione interna, sessioni informative e condivisione della Politica Integrata.

7.3 Comunicazione

La comunicazione interna ed esterna è gestita in conformità alla clausola 7.4 HLS, determinando cosa comunicare, quando, a chi, come e chi ne è responsabile. La Politica Integrata è pubblicata e resa accessibile. I risultati del SGI sono comunicati nel Riesame della Direzione. Il canale di segnalazione (whistleblowing) è attivo e comunicato a tutto il personale (ISO 37001).

7.4 Informazioni documentate

Il sistema documentale del SGI è disciplinato dalla Procedura di Catalogazione e Gestione della Documentazione (TD-SGI-PRO001). La documentazione è organizzata in 8 tipologie (MAN, POL, PRO, IDL, REG, PLN, MOD, DEX) con codifica univoca TD-SGI-XXXNNN_RR. La creazione, l'aggiornamento, il controllo, la distribuzione e il ritiro delle informazioni documentate seguono il ciclo di vita definito nella procedura. Il Manuale SGI e le Politiche sono conservati per l'intera vita del sistema; le procedure e i regolamenti conservano la revisione corrente più le due precedenti; i documenti relativi al Modello 231 sono conservati per 10 anni.

8. Attività operative (cl. 8 HLS)

8.1 Pianificazione e controllo operativo

L'organizzazione pianifica, attua e controlla i processi necessari per soddisfare i requisiti delle prestazioni diagnostiche e per attuare le azioni determinate nella Sezione 6. La pianificazione operativa definisce: i requisiti delle prestazioni (normativa sanitaria, protocolli clinici, requisiti di accreditamento), i criteri di accettazione, le risorse necessarie, i controlli di processo, le informazioni documentate necessarie a dimostrare la conformità. L'output pianificato è adeguato alle operazioni dell'organizzazione. Le modifiche pianificate sono controllate e le conseguenze di modifiche non volute sono riesaminate.

8.2 Erogazione delle prestazioni diagnostiche

L'erogazione delle prestazioni diagnostiche è governata da procedure operative e istruzioni di lavoro specifiche per ciascuna area: diagnostica di laboratorio (fasi pre-analitica, analitica, post-analitica con esecuzione interna dell'intero spettro prestazionale senza service esterni), diagnostica per immagini (programmazione, esecuzione con apparecchiature di ultima generazione, refertazione

multidisciplinare con sistemi RIS-PACS integrati), gestione del paziente (accettazione, prenotazione, accoglienza, comunicazione dei risultati), logistica dei campioni (modello hub & spoke con ottimizzazione dei tempi di trasporto e riduzione della variabilità pre-analitica).

8.3 Fornitori e approvvigionamento

I fornitori esterni che influenzano la qualità delle prestazioni sono valutati e selezionati secondo criteri documentati che includono: capacità tecnica, conformità normativa, affidabilità, requisiti anticorruzione (ISO 37001), requisiti di sicurezza delle informazioni (ISO 27001), requisiti ambientali (ISO 14001) e requisiti di responsabilità sociale (PAS 24000). La predilezione per forme di noleggio operativo e contratti full service per la strumentazione diagnostica è una scelta strategica che garantisce aggiornamento tecnologico continuo e trasferimento del rischio di obsolescenza.

9. Valutazione delle prestazioni (cl. 9 HLS)

9.1 Monitoraggio e misurazione

L'organizzazione determina cosa monitorare e misurare, i metodi di monitoraggio, i tempi di esecuzione e di valutazione dei risultati. Gli indicatori chiave comprendono: tempi medi di refertazione per tipologia di esame, soddisfazione del paziente (NPS), tasso di non conformità analitiche, indice infortunistico e near miss, indicatori ambientali (consumi energetici, rifiuti speciali), KPI di parità di genere, segnalazioni tramite canale anticorruzione, incidenti di sicurezza informazioni. La conformità ai requisiti legali e normativi applicabili è valutata con cadenza almeno annuale.

9.2 Audit interni

L'organizzazione conduce audit interni a intervalli pianificati per verificare la conformità del SGI ai requisiti delle norme applicabili e ai requisiti propri dell'organizzazione, nonché l'efficace implementazione e mantenimento del sistema. Il programma di audit è definito annualmente dal RSGI, tenendo conto dell'importanza dei processi, delle modifiche significative e dei risultati degli audit precedenti. Gli audit sono condotti da auditor qualificati e indipendenti. I risultati sono documentati e comunicati alla Direzione.

9.3 Riesame della Direzione

L'Alta Direzione riesamina il SGI a intervalli pianificati (almeno annuale) per assicurarne la continua idoneità, adeguatezza ed efficacia. Gli input del riesame comprendono: lo stato delle azioni da riesami precedenti, le modifiche nei fattori esterni e interni, le informazioni sulle prestazioni del SGI (soddisfazione delle parti interessate, obiettivi, NC e azioni correttive, audit, fornitori, rischi/opportunità), l'adeguatezza delle risorse, le opportunità di miglioramento. Gli output comprendono le decisioni e le azioni relative al miglioramento, ai cambiamenti necessari e alle risorse. Il Rapporto di Riesame (TD-SGI-PRO002) documenta gli esiti.

10. Miglioramento (cl. 10 HLS)

L'organizzazione determina e seleziona le opportunità di miglioramento e attua le azioni necessarie per soddisfare i requisiti delle parti interessate e accrescerne la soddisfazione. Il miglioramento continuo è il principio unificante del SGI, applicato in modo trasversale a tutti gli standard adottati secondo il ciclo PDCA.

Le non conformità sono gestite con tempestività: l'organizzazione reagisce alla NC, ne valuta la necessità di azioni per eliminare le cause, attua le azioni necessarie, ne riesamina l'efficacia e, se necessario, aggiorna rischi/opportunità e apporta modifiche al SGI. Ogni NC, reclamo e segnalazione è trattata come fonte di apprendimento organizzativo. Le azioni correttive sono

proporzionate agli effetti delle NC riscontrate. Le evidenze sono conservate come informazioni documentate.

11. Architettura documentale del SGI: le 18 aree

La documentazione operativa del SGI è organizzata in 18 aree tematiche, ciascuna corrispondente a una cartella del sistema documentale. Ogni area raggruppa le procedure, le istruzioni, i moduli e i regolamenti pertinenti, garantendo una navigazione logica e una gestione efficiente dell'informazione documentata.

N.	Area	Contenuto e riferimenti normativi
01	Gestione del Sistema	Manuale SGI, procedure di catalogazione documentale, riesame della direzione, gestione delle NC e azioni correttive, miglioramento continuo. Clausole 4, 5, 9.3, 10 HLS.
02	Anticorruzione e Whistleblowing	Procedure anticorruzione, valutazione del rischio corruttivo, due diligence, canale di segnalazione, formazione anticorruzione, protocolli 231. ISO 37001, D.Lgs. 231/2001.
03	Parità di Genere	Politica per la parità di genere, KPI di genere, piano strategico, reporting, conciliazione vita-lavoro, equità remunerativa. UNI PdR 125:2022.
04	Sostenibilità	Politica sociale, assessment PAS 24000, piano miglioramento sociale, rapporti con le comunità, condizioni di lavoro, diritti umani, etica aziendale. PAS 24000:2022, ISO 30415:2021.
05	Sicurezza	Valutazione dei rischi, DVR, gestione DPI, sorveglianza sanitaria, formazione SSL, gestione near miss e infortuni, piani di emergenza. ISO 45001:2018, D.Lgs. 81/2008.
06	Tutela dell'Ambiente	Aspetti ambientali significativi, gestione rifiuti sanitari e speciali, consumi energetici, obiettivi ambientali, compliance ambientale. ISO 14001:2015.
07	Rischio Clinico	Governo clinico, sicurezza del paziente, gestione eventi avversi, appropriatezza diagnostica, protocolli clinici, refertazione. ISO 7101:2023, ISO 9001:2015.
08	Sistema Informativo	Architettura IT, gestione LIS/RIS/PACS, interoperabilità, infrastruttura di rete, help desk, change management IT. ISO 27001:2022.
09	Privacy	Registro trattamenti, DPIA, gestione diritti interessati, data breach, formazione privacy, nomina responsabili trattamento. Reg. UE 2016/679 (GDPR), ISO 27001:2022.
10	Audit	Programma di audit interni, gestione degli audit, qualificazione auditor, reporting, follow-up, audit di seconda e terza parte. Clausola 9.2 HLS.
11	Health Technology Assessment	Valutazione delle tecnologie sanitarie, selezione apparecchiature, analisi costi-benefici, piani di rinnovo tecnologico. ISO 9001, ISO 7101.
12	People	Gestione del personale, selezione, inserimento, formazione, valutazione prestazioni, sviluppo professionale, cultura organizzativa, welfare. PAS 24000, ISO 30415, UNI PdR 125.
13	Finance	Controllo di gestione, reporting finanziario, budgeting, pianificazione, cash flow, covenant monitoring. ISO 9001 cl. 7.1.
14	Operations	Logistica dei campioni, gestione magazzini reagenti e materiali, procurement centralizzato, contratti fornitori, noleggi e leasing. ISO 9001 cl. 8.4.
15	Customer Experience	Gestione del paziente, accoglienza, comunicazione referti, reclami, indagini di soddisfazione, NPS, percorsi di cura. ISO 9001, ISO 7101.
16	Business	Sviluppo commerciale, convenzioni, rapporti con SSR, contratti B2B, medicina del lavoro, welfare aziendale, assicurazioni, marketing sanitario.
17	Accettazione	Procedure di accettazione pazienti, gestione prenotazioni, flussi CUP, gestione code, documentazione sanitaria, consenso informato.
18	Laboratorio di Analisi	Procedure analitiche, controllo qualità interno ed esterno, validazione metodi, gestione strumentazione, calibrazione, gestione campioni, refertazione. ISO 9001, ISO 7101, ISO 15189:2022 (obiettivo accreditamento 2027).

12. Matrice di correlazione norme e processi

La seguente matrice evidenzia la correlazione tra le clausole HLS, gli standard del SGI e le aree documentali, garantendo la copertura completa di tutti i requisiti normativi.

Clausola HLS	9001	45001	14001	37001	27001	7101	PdR125	Area
4. Contesto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	01
5. Leadership	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	01
6. Pianificazione	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	01
7. Supporto	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	01, 12
8. Operatività	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	07, 14, 17, 18
9. Valutazione	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	10
10. Miglioramento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	01
Anticorruzione	–	–	–	✓	–	–	–	02
SSL specifico	–	✓	–	–	–	–	–	05
Ambiente spec.	–	–	✓	–	–	–	–	06
ISMS specifico	–	–	–	–	✓	–	–	08, 09
Parità genere	–	–	–	–	–	–	✓	03
Rischio clinico	–	–	–	–	–	✓	–	07

12. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione modifiche	Approvazione
00	12/04/2026	Prima emissione	Francesco Epifani